PROFESIONAL

EJE 1 · TRANSFORMACIONES DEL CUIDADO Y HUMANIZACIÓN

**Humanización de la atención: elementos clave identificados por pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios. Una revisión sistemática.**

# Cuidar en la era digital: la humanización como eje del cuidado enfermero


**Lic. Caruso Andrea Viviana**

Hospital de Clínicas José de San Martin ,Dermatología


## 1 INTRODUCCIÓN

La incorporación acelerada de tecnología —historia clínica electrónica, telesalud, monitoreo remoto e inteligencia artificial— transforma la práctica enfermera y promete más seguridad y eficiencia (Topol, 2019). Pero también puede desplazar el tiempo de encuentro y reducir el cuidado a tareas y registros.

Humanizar es reconocer a cada persona en su integralidad, su dignidad y su autonomía (Busch et al., 2019), y la OMS (2016) propone reorientar los servicios hacia modelos centrados en la persona. El desafío no es elegir entre tecnología y humanidad, sino integrarlas sin perder el vínculo.

## 2 OBJETIVOS

- **Objetivo general:** analizar los fundamentos teóricos de la humanización del cuidado enfermero ante la transformación tecnológica de los servicios de salud.
- **Específicos:** describir modelos de cuidado centrados en la persona; vincular bioética y derechos del paciente con la práctica; proponer criterios para preservar el vínculo humano.

## 3 METODOLOGÍA

**Diseño:** revisión narrativa con enfoque teórico-reflexivo.

**Fuentes:** obras de referencia en teoría del cuidado y bioética, revisiones sistemáticas sobre humanización, documentos de la Organización Mundial de la Salud y normativa argentina vigente.

**Criterios de selección:** textos que abordaran el cuidado centrado en la persona desde la teoría enfermera, la ética, el marco legal o el impacto de la tecnología en la relación de cuidado.

**Análisis:** lectura crítica y síntesis temática en cuatro ejes: modelos de cuidado, humanización, bioética y derechos del paciente, y vínculo humano ante la tecnología. Los ejes se integraron en un modelo conceptual (Figura 1).

**Aspectos éticos:** trabajo teórico, sin participación de personas ni uso de datos de pacientes.

## 4 DESARROLLO




*Figura 1. Modelo conceptual: la persona y el vínculo terapéutico en el centro del cuidado; la tecnología como mediadora. Fuente: elaboración propia.*

**4**
principios bioéticos que orientan cada decisión de cuidado (Beauchamp y Childress, 2019)

**26.529**
Ley de Derechos del Paciente: trato digno, intimidad, información y autonomía

**Modelos de cuidado.** La teoría del cuidado humano de Watson (2008) concibe el cuidado como relación transpersonal; los modelos centrados en la persona llevan esa mirada a la organización: decisiones compartidas, continuidad y participación de la familia.

**Humanización.** Trato digno, comunicación empática y atención a necesidades emocionales y sociales, no solo clínicas (Busch et al., 2019).

**Bioética y derechos.** Los principios bioéticos se concretan en la Ley 26.529: información sanitaria, consentimiento informado y confidencialidad.

**Vínculo y tecnología.** La tecnología humaniza cuando libera tiempo para el encuentro y deshumaniza cuando lo reemplaza (Topol, 2019).

## 5 CONCLUSIONES

**MENSAJE CLAVE**

**La tecnología no humaniza ni deshumaniza por sí sola: lo que define si el cuidado sigue siendo humano es cómo Enfermería la integra al encuentro con la persona.**

La humanización no es un valor agregado: es una dimensión de la calidad y la seguridad del cuidado. Teoría, bioética y normativa coinciden en poner a la persona y su autonomía en el centro.

Ante la transformación digital, el rol enfermero se resignifica como mediador entre la tecnología y la persona. Limitación: análisis teórico que requiere validación empírica en los servicios.

## 6 APORTE A ENFERMERÍA

Un marco para la gestión y la formación: usar la humanización como criterio al adoptar tecnologías, proteger tiempos de presencia y comunicación, y enseñar bioética y derechos desde situaciones reales. Aplicable desde la internación hasta la atención domiciliaria.

## 7 REFERENCIAS


Beauchamp, T. L. y Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8.ª ed.). Oxford University Press.

Busch, I. M., Moretti, F., Travaini, G., Wu, A. W. y Rimondini, M. (2019). Humanization of care: Key elements identified by patients, caregivers, and healthcare providers. A systematic review. *The Patient, 12*(5), 461–474. https://doi.org/10.1007/s40271-019-00370-1

Ley N.° 26.529. (2009). *Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.* Boletín Oficial de la República Argentina.

Organización Mundial de la Salud. (2016). *Marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona* (A69/39). Asamblea Mundial de la Salud.

Topol, E. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again.* Basic Books.

Watson, J. (2008). *Nursing: The philosophy and science of caring* (ed. rev.). University Press of Colorado.



**Contacto: acviviana@gmail.com**